

	CLASIFICACIÓN Y MANEJO DE REACCIONES ADVERSAS A MEDIOS DE CONTRASTE <i>Procedimientos Imagenológicos con Medios de Contraste Endovenosos</i>	Versión 2.0	Fecha 04/2026
Código: GP1.5-E · Tabla 5	Ref.: Protocolo GP1.5 · ACR Manual on Contrast Media 2024 · SOCHRADI Guía Clínica N°1	DiagnoPRO	

1. OBJETIVO

Establecer la clasificación de las reacciones adversas a medios de contraste endovenosos y las acciones clínicas que debe ejecutar el equipo de Diagnopro ante cada nivel de gravedad, garantizando una respuesta oportuna, organizada y segura para el paciente.

2. CLASIFICACIÓN DE REACCIONES ADVERSAS

Las reacciones adversas se clasifican según su gravedad en cuatro niveles. Esta clasificación orienta la respuesta clínica inmediata:

Nivel	Síntomas y signos característicos	Característica clínica
 LEVE	• Náuseas o vómitos leves • Prurito localizado • Urticaria leve o eritema localizado • Sensación de calor o rubor • Malestar transitorio o cefalea leve	<i>Manifestaciones autolimitadas. Generalmente no requieren tratamiento farmacológico específico. El paciente se encuentra estable y consciente.</i>
 MODERADA	• Broncoespasmo leve (sibilancias audibles) • Hipotensión moderada (PA sistólica 80-90 mmHg) • Edema facial o periorbital sin compromiso de vía aérea • Urticaria generalizada • Vómitos persistentes o intensos • Taquicardia o bradicardia sin compromiso hemodinámico	<i>Pueden requerir tratamiento farmacológico y supervisión médica estrecha, pero no comprometen la vida de forma inmediata.</i>
 GRAVE	• Laringoespasmo o broncoespasmo severo • Edema de glotis con compromiso de vía aérea • Shock anafiláctico (hipotensión grave + síntomas sistémicos) • Arritmias cardíacas graves • Pérdida de conciencia	Comprometen la vida. Requieren intervención médica inmediata, activación del protocolo de emergencia y soporte vital avanzado.

	• Paro cardiorrespiratorio	
 FATAL	• Paro cardiorrespiratorio refractario a maniobras de reanimación • Muerte del paciente a pesar de tratamiento apropiado	<i>Resultado excepcional. La activación inmediata del protocolo de emergencias y el soporte vital son obligatorios desde el primer signo de gravedad.</i>

3. MANEJO CLÍNICO POR NIVEL DE GRAVEDAD

Las reacciones adversas pueden presentarse **durante la inyección del contraste o una vez finalizado el examen**, durante el período de observación posterior. Las acciones descritas a continuación deben ejecutarse de forma inmediata una vez identificado el nivel de reacción. Si la reacción se presenta mientras el contraste aún se está administrando, se deberá detener la inyección como primera medida; si ya fue administrado en su totalidad, se procede directamente desde el manejo clínico.

● REACCIÓN LEVE — Manejo	
1	Si el contraste aún se está administrando, detener la inyección de inmediato. Si ya fue administrado en su totalidad, proceder directamente al paso siguiente.
2	Tranquilizar al paciente. Explicar que los síntomas son leves y generalmente autolimitados.
3	Trasladar al paciente a la sala de recuperación. Mantener en reposo.
4	Iniciar monitorización de signos vitales: presión arterial, frecuencia cardíaca y saturación de oxígeno.
5	Observar durante 30 minutos. Si los síntomas ceden completamente, autorizar el alta con indicaciones post examen (Anexo 4).
6	Si los síntomas persisten o se intensifican, escalar a manejo de reacción moderada.
7	Registrar el evento en el sistema de gestión de DiagnoPRO.

● REACCIÓN MODERADA — Manejo	
1	Si el contraste aún se está administrando, detener la inyección de inmediato. Si ya fue administrado en su totalidad, proceder directamente al paso siguiente.
2	Llamar al médico radiólogo o director técnico de inmediato.
3	Trasladar al paciente a la sala de recuperación. Mantener en reposo, preferentemente en posición semisentada si hay disnea.
4	Iniciar monitorización continua de signos vitales.
5	Mantener el acceso venoso permeable para administración de medicamentos.
6	Administrar la medicación autorizada por la Dirección Médica de DiagnoPRO:

	• Hidrocortisona 200 mg EV
	• Clorfenamina 10 mg EV
7	Continuar observación clínica. Si los síntomas ceden, mantener en observación 60 minutos antes del alta.
8	Si los síntomas no mejoran en 15-20 minutos o progresan hacia signos graves, escalar a manejo de reacción grave y activar el protocolo AOC2.1-1.
9	Registrar el evento en el sistema de gestión.

● REACCIÓN GRAVE — Manejo	
1	Si el contraste aún se está administrando, DETENER la inyección de inmediato. Si ya fue administrado en su totalidad, proceder directamente al paso siguiente.
2	ACTIVAR el protocolo de derivación AOC2.1-1.
3	Llamar al médico radiólogo o director técnico. No dejar solo al paciente en ningún momento.
4	Posicionar al paciente: decúbito supino con piernas elevadas (shock). Si hay disnea, semisentado.
5	Mantener la vía aérea permeable. Administrar oxígeno con mascarilla (6-10 L/min) si está disponible.
6	Mantener el acceso venoso permeable hasta la llegada del equipo de urgencias.
7	Iniciar RCP avanzado si el paciente presenta paro cardiorrespiratorio, hasta llegada del equipo de urgencias.
8	Registrar hora de inicio de síntomas y evolución del paciente.
9	Documentar el evento completo en el sistema de gestión una vez estabilizada la situación.

4. MEDICAMENTOS DE EMERGENCIA AUTORIZADOS — Diagnopro

Los siguientes medicamentos están autorizados por la Dirección Médica de Diagnopro para ser administrados ante reacciones adversas a medios de contraste:

Fármaco	Dosis	Vía	Indicación
Hidrocortisona	200 mg	Endovenosa	Reacción moderada. Corticoide para reducir respuesta inflamatoria.
Clorfenamina	10 mg	Endovenosa	Reacción moderada. Antihistamínico H1 para síntomas alérgicos.

⚠ Consideración importante:

Los medicamentos autorizados por DiagnoPRO (Hidrocortisona y Clorfenamina EV) están indicados para el manejo de reacciones moderadas.

Ante una reacción grave, la conducta institucional es la derivación inmediata al servicio de urgencias y el inicio de RCP avanzado si corresponde.

5. CRITERIOS DE OBSERVACIÓN Y ALTA

Nivel de reacción	Tiempo mínimo de observación	Criterio de alta
● Leve	30 minutos desde la resolución de los síntomas.	Síntomas completamente resueltos. Signos vitales estables. Paciente asintomático.
● Moderada	60 minutos desde la administración del tratamiento farmacológico.	Síntomas resueltos, signos vitales estables y evaluación médica favorable.
● Grave	El alta es responsabilidad exclusiva del equipo de urgencias que recibe al paciente.	Paciente debe ser derivado y no puede retirarse sin evaluación médica externa.

6. REGISTRO Y REPORTE DEL EVENTO

Todo evento adverso debe quedar documentado, independientemente de su gravedad. El registro debe incluir:

✓	Fecha y hora de inicio de los síntomas
✓	Tipo y volumen de medio de contraste administrado al momento del evento
✓	Descripción clínica de los síntomas y nivel de gravedad clasificado
✓	Medidas clínicas aplicadas y medicamentos administrados (nombre, dosis, vía y hora)
✓	Evolución del paciente y tiempo hasta la resolución de los síntomas
✓	Nombre del profesional responsable y nombre del médico que evaluó
✓	Decisión de alta o derivación con fundamento clínico

i Importante:

Los eventos adversos leves también deben registrarse, aunque se resuelvan sin intervención farmacológica.

